

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	帶狀皰疹的照護 Care of Herpes zoster				
編號	A31000-Q03-W-A14	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	107 年 03 月 14 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.6 版/8 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解帶狀皰疹的原因、症狀、常見治療、預防，幾個常見的問題觀念澄清、護理問題與措施以及衛教指導，使具備更適切之照護能力，以提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

帶狀皰疹(Herpes zoster)為潛伏在神經節的水痘帶狀皰疹病毒(varicella-zoster virus, VZV)在病人免疫力低下時，再度活化而產生。病毒來自於過去感染的水痘病毒，初次感染 VZV 會產生水痘，水痘治癒病毒就潛伏在人體神經節。水痘病毒屬於皰疹病毒，醫學上以帶狀皰疹稱呼，俗稱皮蛇(shingles)，會合併有神經痛症狀，一般好發於老人，年紀越大，發病的機會也越大。

（二）原因

當人體因為各種原因，如上呼吸道感染、使用免疫抑制劑、過度勞累、氣候變化，或惡性腫瘤，導致身體免疫力降低時，潛伏於神經節中的 VZV 就會被激活，沿著感覺神經造成皮膚感染，引發皮膚出現水泡和嚴重神經疼痛。

（三）症狀

1. 典型表現：帶狀皰疹病灶通常沿某一感覺神經支配之皮節分布，常見於胸、腰、頸及三叉神經所支配的臉部等位置，多為單側發生。在皮膚出現紅疹前會先有

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	2/8

刺痛、酸痛等前驅性痛感，此為病毒再度活化造成該部位神經發炎所致。因發炎程度不一，疼痛持續時間不同，疼痛程度可從輕微到劇烈疼痛，有些病人會伴隨燒灼、針刺感等感覺異常或在沒有痛覺刺激下產生痛覺等現象。紅疹在 2-3 天後出現，3-5 天內新病灶會陸續增加，最後佈滿該體節，隨著時間紅疹漸轉變成水皰或膿皰，7-10 天後開始乾燥、結痂。少數病例只出現疼痛，無皮膚病灶發生，稱作無皮疹的疼痛。

2. 散布性帶狀皰疹：帶狀皰疹發生在免疫力低下者，會出現散佈性帶狀皰疹，病程將延長，造成病毒血症，病灶不再侷限於單一體節。

（四）鑑別診斷

獨特病徵外觀往往能夠準確診斷出帶狀皰疹，然而當病灶的位置或表現為非典型時，特別是免疫功能低下病人，必須以五種實驗室檢查確認：

1. 病毒培養：皰疹病毒不穩定、易變化，且不容易從水泡中的液體取出，需要較長時間。
2. 直接免疫螢光法(Airect immuno Fluorescence assay)：此法比病毒培養敏感高，便宜且迅速，並且能夠區分單純性皰疹病毒(HSV)或VZV病毒感染。
3. 聚合酶連鎖反應(polymerase-chainreaction, PCR)：PCR能夠偵測水泡液體或組織中的VZV DNA。
4. Tzanck smear：一種組織細胞學法，首先刮取水泡底部組織塗抹於載玻片上，經染色後置於顯微鏡下觀察是否有多核巨細胞，非常快速但無法分辨HSV或VZV。
5. 血清學檢驗：透過血液中IgG抗體瞭解過去是否曾感染過水痘及預防後續的繼發性感染，評估潛在的感染風險，瞭解接種後產生的免疫反應。

（五）常見治療

帶狀皰疹的治療目標是加速癒合，減低急性和慢性疼痛的嚴重度及持續的時間並且減少併發症。治療主要分成兩部分，第一是抗病毒治療，第二是症狀緩解治療，前者主要是使用口服或靜脈注射抗病毒藥劑，後者處置重點則在於疼痛的處理。

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	3/8

使用抗病毒藥劑的好處可以加速皮膚病灶癒合，減少新生水泡產生及病毒的排出和降低急性疼痛的嚴重度。

1. 抗病毒藥物治療：使用抗病毒藥劑的好處在於可以加速皮膚病灶的癒合，減少新生水泡的產、減少病毒的排出和降低急性疼痛的嚴重度，目前建議使用對象為年紀大於 50 歲以上的老人，皮疹分佈範圍超過兩個神經節分佈，或侵犯臉部或眼睛部位時使用。使用時機則是在仍有新皮疹或水泡產生的時候。治療時間通常 7 到 10 天。
2. 類固醇藥物：合併短期使用類固醇可以降低帶狀皰疹產生的疼痛和加速病灶癒合。
3. 急性疼痛治療：輕微疼痛使用非固醇類抗消炎藥或 Acetaminophen 治療，嚴重疼痛使用鴉片類藥物治療，及 Lidocaine 貼布也可緩解疼痛，但要避免貼在病灶處，須貼於完整皮膚處。
4. 眼部併發症治療：發生在三叉神經節 V1 的帶狀皰疹應建議病人至眼科評估。
5. 帶狀皰疹後神經痛的治療：局部使用 Lidocaine、Gabapentin 或 Pregabalin 等抗癲癇藥物、鴉片類藥物、三環抗憂鬱劑以及辣椒素等減緩皰疹後神經痛。

（六）帶狀皰疹預防接種

統計顯示，每三個人就會有一個人罹患帶狀皰疹，每四位罹患帶狀皰疹的病人，就有一種以上的併發症。美國食品藥物管理局在 2006 年，台灣衛生福利部在 2013 年核准了帶狀皰疹疫苗，疫苗可以提升帶狀皰疹病毒的免疫力。

（七）護理問題

1. 疼痛不適/神經受損與發炎造成疼痛有關
2. 皮膚狀態不完整/帶狀皰疹病毒導致皮膚受損有關
3. 焦慮感受/與不了解帶狀皰疹有關
4. 尋求（特定的）健康協助/與不了解帶狀皰疹有關

（八）護理措施

1. 疼痛不適/神經受損與發炎造成疼痛有關

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	4/8

- (1) 持續監測生命徵象。
- (2) 主動傾聽，抱持不批評及同理的態度，維持一致性及真誠態度。
- (3) 觀察有無非語言疼痛生理反應。
- (4) 每班評估病人疼痛指數，疼痛部位、性質、時間。
- (5) 鼓勵病人表達疼痛，並依醫囑給予止痛藥物，及監測疼痛控制情形。
- (6) 依 0-10 分數字型評分量表，評估病人疼痛程度並加以記錄。
- (7) 評估頭痛加劇原因。
- (8) 協助採舒適臥位，避免不當姿勢導致傷口壓迫或牽扯。
- (9) 教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。
- (10) 提供轉移注意力的技巧如：音樂、閱讀、聊天，以減輕疼痛。
- (11) 鼓勵家屬多陪伴，增加安全感。

2. 皮膚狀態不完整/帶狀皰疹病毒導致皮膚受損有關

- (1) 持續監測生命徵象。
- (2) 依醫囑以無菌技術換藥，每次換藥前，評估傷口變化及分泌物量、顏色、性質，傷口周圍皮膚，並詳加記錄。
- (3) 教導家屬傷口照護，並回覆示教。
- (4) 教導選擇高蛋白、高維生素飲食，促進傷口修復再生。
- (5) 依醫囑按時給予抗生素使用。

3. 焦慮狀態/與帶狀皰疹不了解

- (1) 鼓勵病人澄清及信念。
- (2) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (3) 引導病人說出心中疑慮、擔憂及害怕。
- (4) 適時予回應問題。
- (5) 請醫師解釋疾病目前狀況及影響。
- (6) 換藥時陪伴並安撫情緒。
- (7) 主動傾聽，抱持不批評及同理的態度，維持一致性及真誠態度。

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	5/8

(8) 時常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

(9) 增加社會互動之機會。

4. 尋求（特定的）健康協助/與帶狀皰疹不了解

(1) 評估病人及家屬的認知。

(2) 給予衛教單張並共同討論日常生活照顧的方法，衛教過程中澄清病人及家屬的疑問，並鼓勵提出問題。

(3) 教導病人及家屬瞭解造成帶狀皰疹發生的原因及治療目標。

(4) 教導傷口護理。

(5) 教導穿著寬鬆衣物，避免傷口壓迫。

(6) 衛教病人認識服用藥物的作用及副作用，及按時服藥的重要性。

(7) 教導病人選擇高蛋白、高維生素飲食。

（九）衛教指導

1. 帶狀皰疹的護理：誘發帶狀皰疹發作的原因：因為各種原因，導致身體免疫力降低時，潛伏於神經節中的 VZV 就會被激活，沿著感覺神經造成皮膚感染，引發皮膚出現水泡和嚴重神經疼痛。

2. 飲食須知：教導選擇高蛋白、高維生素飲食。

3. 不論傷口大小，需注意是否有傷口感染現象發生，每班觀察傷口紅、腫、熱、痛或不正常分泌物情形及傷口恢復狀況。

4. 隨著年紀的增長，帶狀皰疹所導致疼痛的風險與合併症會隨之提高，後遺症之皰疹後神經痛問題可能會持續數月至數年。

5. 治療上，對於帶狀皰疹的併發症是以抗病毒藥物為主，最好在皮疹發生後72小時之內使用，選擇適當的止痛藥物以減少疼痛，必要時應諮詢皮膚科。

6. 在傷口未結痂前，建議避免接觸尚未發生水痘以及接種水痘疫苗的人，在預防方面，接種帶狀皰疹疫苗可以降低罹病的風險並有效預防各項併發症。

（十）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳韻如、謝嘉娟、陳韋良(2022)．帶狀疱疹病毒感染老年人引發併發症．台灣老年醫學暨老年學會雜誌，17(1)，72－83。
- (二) 王懋哲、陳志昊(2020)．顏面神經麻痺及顏面神經神經鞘瘤．臨床醫學月刊，86(4)，601－606。
- (三) 蔡謹如、陳曦、蔡宛真、王詩涵(2020)．帶狀疱疹治療原則與新型基因重組次單元疫苗介紹．臺灣臨床藥學雜誌，28(2)，77－84。
- (四) CDC(2021):Diagnosis & Testing of Herpes Zoster. <https://www.cdc.gov/shingles/hcp/diagnostesting.html>. Accessed May 6, 2021.

七、附件

(略)

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
107.03.14	1.0	新制定	107 年 03 月 14 日護理長會議通過
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.1	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七、八目之 1 疼痛改為急性疼痛。 3. 第三項第八目之 2(6)刪除。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.02.14	1.2	第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過； 108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布
109.08.18	1.3	第三項第九目之 5 說明內容修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	1.4	1. 第三項第七目、第八目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.5	第三項第七目之 4、第八目之 4.護理問題修辭。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	帶狀皰疹的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A14	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
114.10.08	1.6	第六項參考資料第三目刪除。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。